

Hierarchia *ekspozycji*

Drabina sytuacji, których unikasz. Pokonujesz od dołu — bez przeskakiwania, bez zachowań zabezpieczających.

CZAS: 30 min planowania + 6-10 tyg. wdrożenia Po pracy z modelem A/B

ŹRÓDŁO: Abramowitz & Braddock (2007); Furer & Walker (2008); Foa (2007)

JAK UŻYWAĆ

Wypisz 10 sytuacji, których **unikasz z lęku zdrowotnego** (czytanie ulotki leku, oglądanie filmu o raku, badanie krwi). Oceń SUDS 0-100 dla każdej. Uporządkuj od najniższej. Pracuj **od dołu**: każdą sytuację powtarzaj, aż SUDS spadnie o 50%.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja (ang. *exposure therapy*) to **najsilniejsza** interwencja w zaburzeniach lękowych — $d > 1.0$ (Olatunji 2014). Mechanizm: uczenie hamujące (ang. *inhibitory learning*, Craske 2014): mózg uczy się nowego skojarzenia („ten bodziec NIE oznacza zagrożenia”), które wygasza stare. **Klucz:** bez zachowań zabezpieczających (sprawdzanie pulsu, telefon do bliskich) — inaczej mózg nie zarejestruje korektywnej informacji. NNT ekspozycji w lęku zdrowotnym ≈ 3 (Cooper 2017).

01 Skala SUDS — subiektywna jednostka cierpienia

SUDS (ang. *Subjective Units of Distress*, Wolpe 1969): subiektywna ocena lęku 0-100. Używaj jej do każdej pozycji hierarchii — to **obiektywny** sposób oszacowania, co jest łatwe, a co trudne.

0-20

Łatwe

mały niepokój

21-40

Średnie

wyczuwalne

41-60

Trudne

napięcie

61-80

Wysokie

silny lęk

81-100

Maksymalne

panika

02 Typowe ekspozycje — pomysły do hierarchii

INFORMACYJNE — ŁAGODNE

Czytanie ulotki leku, oglądanie reklamy leku, czytanie artykułu o objawach grypy, krótka rozmowa o zdrowiu z bliskim.

MEDYCZNE — ŚREDNIE

Wejście do apteki, mijanie szpitala, oglądanie zdjęcia chorego (nie znajomy), przeczytanie statystyk choroby ogólnie.

WYOBRAŻENIOWE — WYŻSZE

Wyobrażenie diagnozy raka, pisanie listu „jakbym dowiedział/-a się o chorobie”, scenariusz najgorszy.

REALNE — NAJWYŻSZE

Wizyta na oddziale onkologicznym (jako odwiedzający), oddanie krwi, badanie krwi profilaktyczne, mammografia / USG.

03 Moja hierarchia — 10 stopni

Wypisz **swoje** sytuacje. Oszacuj SUDS dla każdej. Po wypisaniu wszystkich — uporządkuj od najniższego SUDS do najwyższego, numerując od 1 (najłatwiejsze).

#	SYTUACJA <i>konkretnie: co, gdzie, jak długo</i>	SUDS 0–100	ZACHOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE DO PORZUCENIA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

04 Zasady — jak prowadzić ekspozycję

ZASADA 1 · OD DOŁU

Bez przeskakiwania. Pozycja #2 dopiero, gdy #1 osiągnęła habituację (SUDS spadł o 50%).

ZASADA 2 · POWTARZAJ

3–5 razy tę samą ekspozycję, dopóki SUDS nie spadnie z np. 60 do 30. Jednorazowo nie działa.

ZASADA 3 · BEZ ZABEZPIECZEŃ

Bez sprawdzania pulsu, bez telefonu do partnera w trakcie, bez Google po. Inaczej mózg uczy się: „przetrwiałem dzięki sprawdzeniu”.

ZASADA 4 · WYTRZYMAJ

Nie przerywaj, dopóki SUDS sam zacznie opadać (zwykle 15–45 min). Wyjście w panice = wzmocnienie unikania.

Klucz: nie chodzi o to, żeby się *nie bać* w trakcie ekspozycji — chodzi o to, żeby **zostać** mimo strachu i pozwolić mózgowi nauczyć się nowego skojarzenia. Craske (2014, uczenie hamujące, ang. *inhibitory learning*): wysoki SUDS w trakcie ekspozycji = *lepsze* uczenie się, nie gorsze. „Im więcej dyskomfortu, tym więcej terapii”.